

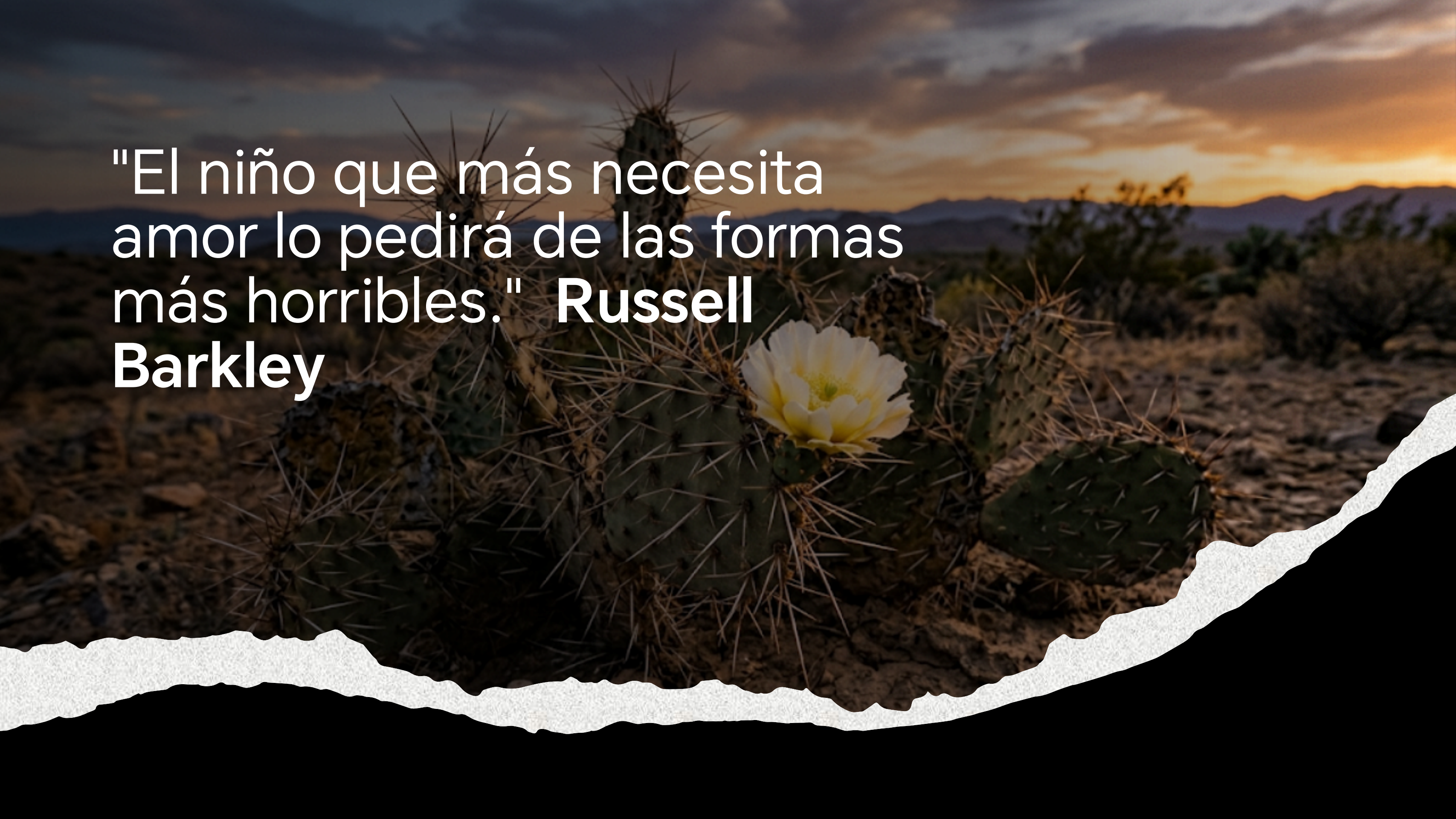


TRASTORNOS DISRUPTIVOS, DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA



Mirna Marin
8-703-625



A desert landscape at sunset. In the foreground, a cholla cactus with a single yellow flower is prominent. The background shows a vast desert with mountains under a dramatic, orange and grey sky. The bottom of the image is torn, revealing a black background where the quote is placed.

"El niño que más necesita
amor lo pedirá de las formas
más horribles." **Russell
Barkley**

TRASTORNOS DISRUPTIVOS, DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA

Se trata de un grupo de trastornos que se caracterizan por diversas dificultades para controlar la agresividad, el autocontrol y los impulsos



TRASTORNOS DISRUPTIVOS, DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS Y DE LA CONDUCTA



Desinhibición conductual



Agresividad



**Conflictos con la
autoridad**



Violación de normas

PRINCIPALES TRASTORNOS DEL GRUPO

Trastorno Negativista Desafiante (TND): Se caracteriza por un patrón de enfado, irritabilidad, discusiones y actitud desafiante hacia la autoridad.

Trastorno Explosivo Intermitente (TEI): Arrebatos de ira desproporcionados e impulsivos ante situaciones menores.

PRINCIPALES TRASTORNOS DEL GRUPO

Trastorno de la Conducta (TC): Un patrón más grave que incluye agresión, robo, engaño y violación grave de las normas.

Piromanía y Cleptomanía: Impulsos irresistibles de provocar incendios o robar objetos sin valor económico, respectivamente

Etiología de los Trastorno Disruptivos, Control de Impulso y De Conducta

Factores genéticos y fisiológicos: Diferencias en el funcionamiento del cerebro, sistema límbico y la autorregulación.

Factores ambientales: crianza inconsistentes, exposición a violencia.

Función comunicativa: falta de habilidades de comunicación.

CRITERIOS DIAGNÓSTICO

Trastorno	Enfoque Principal	Edad Típica de Inicio	Duración Mínima	Comportamiento Clave	Objetivo / Motivación
Negativista Desafiante (TND)	Desobediencia y actitud desafiante.	Infancia (preescolar/escolar).	6 meses	Enfado, discusiones con autoridad y vengatividad.	Resistencia a las normas; conflicto interpersonal.
Explosivo Intermitente (TEI)	Falta de control de impulsos agresivos.	Adolescencia temprana (tardía infancia).	3 meses (frecuencia variable)	Arrebatos de ira desproporcionados e impulsivos.	Liberación de tensión; no es premeditado.
De la Conducta (TC)	Violación de derechos ajenos y leyes.	Infancia o adolescencia.	12 meses	Agresión física, robo, engaño y crueldad.	Control, ganancia material o violación de normas.
Cleptomanía	Robo impulsivo.	Adolescencia o adultez joven.	Recurrente	Robo de objetos que no tienen valor ni utilidad.	Alivio de la tensión interna al robar.
Piromanía	Provocación de incendios.	Desconocida (poco frecuente).	Recurrente	Fascinación y provocación deliberada de fuego.	Placer o gratificación al ver el fuego

SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON TRASTORNO DEL CIE II

Característica	DSM-5 (APA)	CIE-11 (OMS)	Relación / Similitud
Categoría General	Trastornos disruptivos, del control de los impulsos y de la conducta.	Trastornos del comportamiento disruptivo y disocial.	Similitud: Ambas ven la falta de control conductual como el eje central.
Trastorno Negativista Desafiante (TND)	Incluye tres dimensiones: enfado/irritabilidad, desafiante y vengativo.	Se divide en dos variantes: con o sin irritabilidad crónica.	Diferencia: La CIE-11 da más peso a la desregulación emocional (irritabilidad).
Trastorno de la Conducta (TC)	Nombre único: Trastorno de la Conducta.	Se denomina Trastorno Disocial.	Similitud: Los criterios (robo, agresión, mentira) son prácticamente idénticos.
Especificadores de Empatía	Utiliza "Con emociones prosociales limitadas".	Utiliza "Con rasgos de frialdad e insensibilidad"	Similitud: Ambas identifican este subgrupo como de mayor riesgo y peor pronóstico.
Trastorno Explosivo Intermitente (TEI)	Incluido en esta categoría.	Incluido bajo "Trastornos del control de los impulsos".	Diferencia: La CIE-11 lo separa ligeramente del grupo disocial puro.
Contexto del Diagnóstico	Se enfoca en la presencia de síntomas individuales.	Enfatiza que el comportamiento debe ser persistente y no una reacción aislada al entorno.	Similitud: Ambas requieren que el daño sea clínicamente significativo.

ESTADÍSTICAS ACTUALES NACIONALES E INTERNACIONALES

Indicador	Internacionales (OMS / OPS)	Nacionales (Panamá - MINSA / IPHE)
Prevalencia General	Se estima que 1 de cada 7 jóvenes (10-19 años) vive con un trastorno mental. Los de conducta son el grupo más frecuente.	El 15% - 18% de la población escolar presenta necesidades de apoyo por conductas disruptivas.
Trastorno Negativista (TND)	Afecta aproximadamente al 3.3% de la población infantil global.	Es la 2ª causa de consulta en psiquiatría infantil del INSAM, tras el TDAH.
Trastorno de la Conducta (TC)	Prevalencia del 2% al 5%. Es la principal causa de años perdidos por discapacidad en adolescentes varones.	Representa cerca del 12% de los casos atendidos en los Gabinetes Psicopedagógicos del MEDUCA/IPHE.
Relación por Sexo	Predominio masculino de 3:1 en TND y hasta 4:1 en Trastorno de la Conducta.	En centros como el IPHE, la relación en programas de conducta es de 4 hombres por cada 1 mujer.
Comorbilidad	El 40% de los casos internacionales coexiste con TDAH o trastornos de ansiedad.	El MINSA reporta que 3 de cada 10 pacientes con conducta disruptiva tienen un diagnóstico previo de TDAH no tratado.

Tratamiento...

Nivel de Intervención	Estrategia Clave	Objetivo
Familiar	Entrenamiento conductual	Cambiar la dinámica de interacción y reducir el conflicto.
Individual	Terapia cognitiva	Desarrollar autocontrol y resolución de problemas.
Escolar	Planes de manejo de conducta	Mejorar la adaptación social y el rendimiento académico.
Médico	Farmacoterapia (opcional)	Estabilizar la impulsividad química en casos graves.

Estilos de crianza y conductas disruptivas en niños de educación básica de Zepita, Perú (2025)

Fuente:
<https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v9i37.978>

Categoría	Detalle de la Investigación
Objetivo	Determinar la relación entre los estilos de crianza y los comportamientos disruptivos en niños de 3 a 5 años.
Ubicación	Distrito rural de Zepita, Puno (Perú), publicado en SciELO Bolivia.
Metodología	Enfoque cuantitativo, de tipo correlacional y diseño no experimental. Se utilizaron cuestionarios como el PCRI-M y CBCL.
Estilo Predominante	Se identificó que el 60% de los padres evaluados aplican un estilo autoritario.
Hallazgo Principal	El estilo autoritario se asocia con mayores niveles de problemas conductuales y emocionales, afectando la atención y aumentando la agresividad.
Factores Protectores	Dimensiones como el apoyo, la satisfacción con la crianza, la comunicación y la disciplina positiva influyen directamente en un desarrollo saludable.

FAMOSOS QUE PRESENTAN EL DIAGNÓSTICO

Famosos que presentan el Diagnóstico

Michael Phelps



TDAH (Variante Impulsiva)

Aunque es un trastorno del neurodesarrollo, sus síntomas de hiperactividad y falta de control se manifestaban como conductas disruptivas graves en el aula antes de ser tratado.

Will Smith



TDAH e Impulsividad

Se describía como el "niño problema" que no podía dejar de interrumpir, lo que hoy se clasifica dentro de las conductas disruptivas asociadas a la impulsividad.

Winona Ryder



Cleptomanía

Diagnosticada tras un incidente mediático; este es un trastorno disruptivo del control de los impulsos que se manifiesta en el hurto recurrente de objetos innecesarios.

TRASTORNO DE CONDUCTA



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5) (5.ª ed.). Editorial Médica Panamericana.

Organización Mundial de la Salud. (2022). Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (11.ª ed.).

<https://icd.who.int/browse11/l-m/es>

Fuente: <https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v9i37.978>

